Provável cálculo que migrou. Hepatite, improvável. Imagem da via biliar, sempre.

Mulher de 50 anos, colecistectomizada há 9 anos. Dor biliar súbita, transaminases que dispararam em horas com GGT dez vezes o limite, bilirrubina normal e via biliar fina na tomografia: é o retrato do cálculo que atravessou a papila. A leucocitose, já em queda, preenche só colangite suspeita por Tóquio 2018, sem critério de imagem. Falta provar que não ficou cálculo para trás.

BILIRRUBINA TOTAL

0,8

Dosada uma vez, até 6 h após a dor

Cedo demais para excluir obstrução: a bilirrubina sobe mais devagar que as transaminases e não foi repetida em D1.

ALT (TGP)

281

Subiu de 188 até D1

Hepatocelular (índice R acima de 5 em D1), cerca de 7 vezes o limite habitual de 40 U/L. AST estável em 292 e 299: a liberação seguia até perto de D1; uma queda às 15h30 marcaria o fim.

LEUCÓCITOS

14,5 mil

Caiu de 18,8 mil até D1

Com enzimas altas, preenche só "colangite suspeita" de Tóquio 2018 (sem imagem); grau leve se a albumina for normal. Charcot falta em 3 de 4 colangites.

O que o quadro tem, e o que não tem

A favor do cálculo que migrou tem

- Dor epigástrica súbita, para o dorso, que cede em horas: dor biliar típica
- AST acima da ALT cedo, ALT quase igual em D1: lesão abrupta (obstrução, isquemia)
- GGT dez vezes o limite já em até 6 h (colestase prévia?), FA quase normal
- Leucocitose neutrofílica que cai com a desobstrução

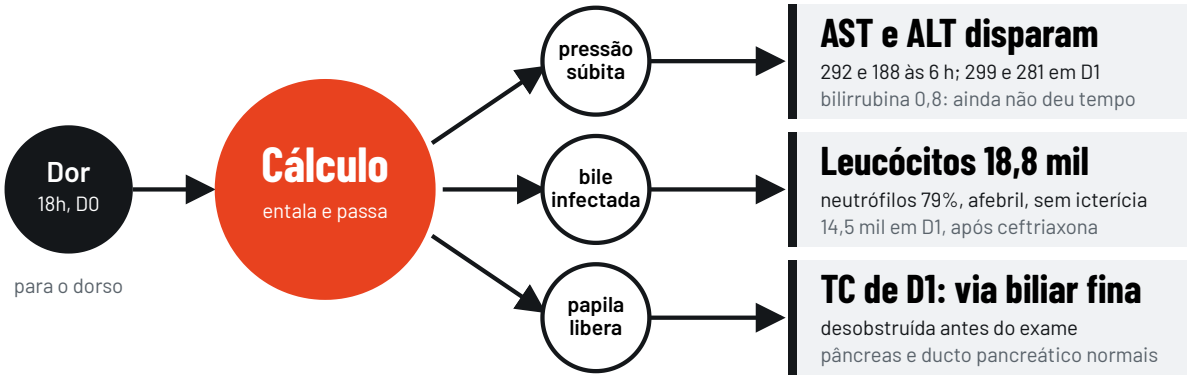
Contra hepatite aguda não tem

- Pródromo de febre, mal-estar e náusea, típico da hepatite A
- Icterícia: atinge mais de 70% dos adultos com hepatite A
- ALT subindo por dias à frente da AST; aqui a AST liderou desde as primeiras horas
- Fármaco: nenhum conhecido antes da dor (dúvida 3); dipirona leva dias a meses
- Leucocitose marcada, rara na hepatite aguda (Tóquio 2018)

Pancreatite improvável: lipase 52,6 até 6 h e pâncreas normal na TC de D1; lipase normal às 15h30 afasta. HBsAg e anti-HCV rápidos não reagentes; anti-HCV não exclui fase aguda. Falta anti-HAV IgM (Ministério da Saúde).

O mais provável: o cálculo passou antes da tomografia.

A sequência explica cada exame. O cálculo entala na papila, a pressão na via biliar sobe de repente e o fígado libera transaminases em horas, não em dias. Quando o cálculo atravessa, o colédoco volta ao calibre normal antes da tomografia e a bilirrubina nem chega a subir. Fica o rastro: GGT alta e leucócitos caindo.



tudo em menos de um dia

O que o desenho não mostra: um segundo cálculo pode ter ficado no colédoco sem dilatá-lo; só colangiorressonância ou ecoendoscopia respondem.

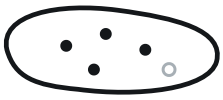


CÁLCULO QUE MIGROU

Encaixa, menos a GGT precoce

Obstrução de horas: transaminases sobem e caem rápido, e a bilirrubina só sobe se a obstrução dura. Leucócitos caem ao desobstruir.

DOR	Súbita, cólica, para o dorso, cede em horas.
ENZIMAS	Sobem em horas, hepatocelulares no início e colestáticas depois (ACG 2021); um terço passa de 500.
TEMPO	Nove anos de cirurgia: após 3 anos, cálculo de colédoco é a causa mais comum de dor tardia (Roma V).
PRÓXIMO PASSO	Colangiorressonância ou ecoendoscopia; CPRE só com cálculo visto.



HEPATITE AGUDA

Não cabe na dor nem na leucocitose

Lesão difusa e lenta. Começa com febre, mal-estar e náusea; a dor, quando existe, é desconforto, não cólica. Transaminases chegam a 25 a 100 vezes o normal (Guia de Vigilância do Ministério da Saúde); icterícia em dias.

DOR	Surda, sem irradiação, após o pródromo.
ENZIMAS	Sobem por dias e caem cerca de 10% ao dia; bilirrubina sobe junto.
IMAGEM	Fígado normal ou aumentado; via biliar fina.
PRÓXIMO PASSO	Anti-HAV IgM agora; anti-HBc, HCV-RNA, anti-HEV e autoimunidade se subir.

Se a AST cair às 15h30, a liberação parou.

A coleta cai cerca de 21 horas após a dor. A AST tem meia-vida de 17 horas e a ALT, de 47: se a obstrução cessou em D1, a AST já vem em queda e a ALT pode estar estável, perto do pico. As duas subindo juntas não cabem no cálculo que passou. E a queda não prova colédoco limpo: melhora dos testes não previu passagem do cálculo nos estudos. A colangiorressonância fica de pé nos dois cenários.

AST CAIU, ALT ESTÁVEL

Agressão em queda. Alta é opção do médico.

Relação AST/ALT abaixo de 1, bilirrubina normal, sem dor nem febre: agressão resolvida; cálculo residual ainda não afastado.

IMAGEM	Colangiorressonância com data curta e marcada: cálculo que fica complica o dobro; em colecistectomizada, a CPRE é o tratamento definitivo.
ANTIBIÓTICO	Tóquio 2018: 4 a 7 dias após o controle da fonte, com troca para via oral em quem come. Contar a passagem espontânea como fonte controlada é extrapolação. Decisão do médico assistente.
RETORNO	Febre, icterícia, colúria ou dor de novo: voltar no mesmo dia.

AS DUAS SUBIRAM

Obstrução persiste, ou não é cálculo.

AST e ALT ainda em subida franca, ou bilirrubina agora alta: o colédoco segue obstruído, contínuo ou intermitente.

IMAGEM	Colangiorressonância ou ecoendoscopia antes da alta. CPRE só se mostrar cálculo.
ANTIBIÓTICO	Opção: manter (colangite suspeita). Sem resposta em 24 h ou cálculo visto, Tóquio manda considerar drenagem precoce.
VIA FINA	Se a bilirrubina seguir normal e a imagem vier limpa: anti-HAV IgM e revisar fármacos; hepatite volta à lista.
SE REPETIR	Nova crise biliar com enzimas altas e imagem limpa: distúrbio do esfíncter de Oddi (Roma V, 2026), conduta eletiva. CPRE empírica não tem respaldo.

D0, até 6 h

AST 292, ALT 188: AST na frente, lesão em curso. Bilirrubina 0,8, lipase 52,6.

D1, manhã

AST 299, ALT 281: AST estável, ALT ainda sobe; a liberação não tinha parado em D0. Leucócitos de 18,8 para 14,5 mil.

15h30

Esperado se parou de manhã: AST perto de 220, ALT perto de 250, AST/ALT abaixo de 1.

Estimativa pelas meias-vidas (AASLD) e pelo NACB: na obstrução, as enzimas normalizam em até 10 dias mesmo se ela persiste; na hepatite viral caem só cerca de 10% ao dia. A hora da coleta de D1 muda a conta. A bula da ceftriaxona lista aumento de enzimas hepáticas como reação comum: uma subida discreta, sozinha, não fecha nada.

Em aberto: provar que não sobrou cálculo.

Cálculo segue o mais provável. SBH e ASGE pedem imagem da via biliar sem CPRE: ultrassom e tomografia perdem boa parte dos cálculos pequenos.

Dúvidas ao médico

1. Valores de referência do laboratório para ALT, AST e GGT. Os múltiplos daqui usam 40 U/L.
2. Hora da coleta de D1. Define quanto a AST deveria ter caído até as 15h30.
3. Dipirona, chás ou suplementos nas semanas antes da dor? "HEV" no prontuário é hidratação venosa?
4. Ceftriaxona: dose única ou mantida? Tóquio prevê 4 a 7 dias após controle da fonte.
5. Diâmetro do colédoco nos laudos. ASGE: dilatado acima de 8 mm em colecistectomizada; Roma V: 13 mm, a validar.

Opções

1 Coleta das 15h30 com bilirrubina total e frações, FA, GGT, PCR, albumina e anti-HAV IgM, além de AST e ALT; lipase se couber.

2 Se a AST caiu: alta com colangiorressonância marcada, orientação de retorno e antibiótico definido pelo médico.

3 Se as duas subiram: colangiorressonância ou ecoendoscopia antes da alta, com cirurgia e endoscopia; CPRE só com cálculo visto.

O que acrescentar à coleta das 15h30

DECIDE

Bilirrubina total e frações

Nunca foi repetida; é o item que as diretrizes pesam.

COMPLETA O QUADRO

FA e GGT | **PCR e albumina** | **Anti-HAV IgM**

FA e GGT: a colestase ainda cresce? PCR e albumina: critérios de Tóquio 2018. Anti-HAV IgM: a sorologia que falta. Lipase, se couber: a primeira pode ter sido colhida antes de subir.

> **POR QUE BILIRRUBINA NORMAL NÃO EXCLUI CÁLCULO**
>
> Na ASGE de 2019 (a CONITEC 471 ainda usa a versão de 2010), bilirrubina acima de 4 mg/dL só pesa junto com colédoco dilatado. Testes hepáticos alterados, sozinhos, já põem a paciente na faixa intermediária, cuja resposta é colangiorressonância ou ecoendoscopia, não CPRE direta.

Fontes lidas em outubro de 2026. Brasil: Ministério da Saúde, Guia de Vigilância em Saúde (6ª ed., 2024), PCDT de hepatite C (2026) e Manual de Diagnóstico das Hepatites Virais (2018) · CONITEC 471/2019, CPRE na coledocolitíase · SBH, Manual de Doenças Colestáticas (2019) e Guia 2026 · bulas aprovadas pela ANVISA: ceftriaxona (out/2026) e dipirona (2025-2026). Sem diretriz brasileira de coledocolitíase, colangite ou transaminases agudas (SBH, FBG, CBC, CBCD, SOBED). Internacionais, edição vigente conferida: ASGE 2019 · ESGE 2019 · Tokyo 2018 · ACG 2017 e revisão Gastroenterology 2026 · AASLD 2008 e NACB 2000 (cinética das enzimas) · metanálise Mohamed 2023 · Roma V 2026 · Atlanta 2013, ACG 2024, IAP 2025 e ibero-latino-americana 2026 · ACG 2021 e EASL 2019 (fármacos) · EASL 2018 e 2025 · CDC 2026. Item a item em verificacao-diretrizes.md. Sem dado de paciente; decisão clínica do médico assistente.